

	FORMULÁRIO DE SEPSE	Código: FORM-CGMP-QUA-008 = 2
		Integridade: Relevante
		Disponibilidade: Pública
		Revisão: 2
		Data da elaboração: 25/04/2025

IDENTIFICAÇÃO	DATA E HORA DA ABERTURA	PACIENTE:	
		FILIAÇÃO:	
		DATA DE NASCIMENTO:	PRONTUÁRIO:
		() CLASSIF. DE RISCO	
		() PRONTO-ATEND.	
		() OBSERVAÇÃO	
	() SALA VERMELHA		
		carimbo e assinatura do(a) médico(a) ou enfermeiro(a)	

NEWS	FR	SAT O2	USO DE O2 () SIM () NÃO	TEMP	PA	FC	ALT. CONSC. () SIM () NÃO	NEWS
	() PRONTO-ATENDIMENTO () CHEFE DE EQUIPE							
	HORA DA AVALIAÇÃO:							
	() CONFIRMA ABERTURA* () DESCARTA SEPSE**							
	NEWS AVALIADO:							
	* indicar foco infeccioso no verso ** justificar em prontuário							
				carimbo e assinatura do(a) médico(a)				

REPOSIÇÃO VOLUMÉICA	() INDICADA* () NÃO INDICADA () CONTRAIND.**	
	* 30ml/kg se PAS ≤ 90 e/ou PAM ≤ 65 e/ou sinais de hipoperfusão ou choque	
	** Justificar em prontuário	
	VOLUME PRESCRITO:	
	HORA DE INÍCIO:	
	VOLUME FINAL ADMINISTRADO:	
ATB	- Iniciar em até 60 minutos após a abertura do protocolo	carimbo e assinatura do(a) técnico(a) de enfermagem e do(a) enfermeiro(a)
	- Recomendação: 02 acessos periféricos calibrosos (nº 14, 16 ou 18)	
	HORA DO INÍCIO DO ANTIBIÓTICO:	
	HORA DO FIM DO ANTIBIÓTICO:	
- Iniciar em até 60 minutos após a abertura do protocolo		carimbo e assinatura do(a) técnico(a) de enfermagem e do(a) enfermeiro(a)

LAB	HORA DA ENTREGA DOS EXAMES NO LABORATÓRIO:	carimbo e assinatura do(a) analista do laboratório
	- Coletar em até 15 minutos da abertura do protocolo	

RESULTADO	HORA DA LIBERAÇÃO DO LAUDO NO SISTEMA:	carimbo e assinatura do(a) enfermeiro(a) / médico(a) / técnico do protocolo
	- A liberação do exame deve ocorrer em até 45 minutos	

DVA	() PRONTO-ATENDIMENTO () CHEFE DE EQUIPE	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
	HORA DA REAVALIAÇÃO:	
	NEWS REAVALIADO:	
	() PERMANECE NO EIXO 1 E AGUARDA EXAMES	
	() OBSERVAÇÃO NO EIXO 2	
	DROGA VASOATIVA INDICADA: () SIM () NÃO	
- Registrar critérios de indicação em prontuário		carimbo e assinatura do(a) médico(a)

AVAL. MÉDICA C/ EXAMES	() PRONTO-ATENDIMENTO () CHEFE DE EQUIPE	carimbo e assinatura do(a) médico(a)	
	HORA DA REAVALIAÇÃO:		
	NEWS FINAL:		
	HIPÓTESE DE SEPSE: () MANTIDA () DESCARTADA		
	DESFECHO		() ALTA MELHORADA
			() OBSERV. NO EIXO 2
() EVASÃO () ÓBITO			



FORMULÁRIO DE SEPSE

Código: FORM-CGMP-QUA-008 = 2

Integridade: Relevante

Disponibilidade: Pública

Revisão: 2

Data da elaboração: 25/04/2025

PADRONIZAÇÃO FARMACÊUTICA DE ANTIBIOTICO DE ACORDO COM O FOCO INFECCIOSO

O preenchimento deste documento não dispensa a prescrição padrão no sistema eletrônico. Fica a critério do(a) médico(a) a troca da antibioticoterapia aqui sugerida de acordo com o quadro clínico do paciente e alergias.

ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ ACOMPANHAR O PACIENTE DURANTE TODO O ATENDIMENTO NAS PRIMEIRAS 6 HORAS.

	PNEUMONIA COMUNITÁRIA	
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV + Azitromicina 500mg: 01 CP VO	
	() Opção 2: Levofloxacino 500mg: 01 bolsa e meia (750mg) EV - Evitar se evidência de IRA ou DRC	
	PNEUMONIA BRONCOASPIRATIVA	
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV + Clindamicina 600mg: 01 FA em 100ml de SF 0,9%, EV	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
	INSTITUCIONALIZADO(A), DPOE/OU INTERNAÇÃO RECENTE (ALTA HÁ MENOS DE 15 DIAS)	
	() Opção 1: Cefepime 2g: 01 FA em 100ml de SF 0,9% EV	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
ABDOMINAL	PERITONITE BACTERIANA ESPONTÂNEA	
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
	INFECÇÃO LOCALIZADA, PERITONITE BACTERIANA SECUNDÁRIA, ABDOME AGUDO	
	() Opção 1: Ciprofloxacino 200mg: 02 bolsas EV + Metronidazol 500mg: 01 bolsa EV - Evitar se evidência de IRA ou DRC	
	() Opção 2: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml SF 0,9% EV + Metronidazol 500mg: 01 bolsa EV	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
URINÁRIO	INFECÇÃO COMUNITÁRIA	
	() Opção 1: Ciprofloxacino 200mg: 02 bolsas EV - Evitar se evidência de IRA ou DRC	
	() Opção 2: Ceftriaxona 1g: 02 FA + 100ml SF EV	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
	INTERNAÇÃO PRÉVIA COM ALTA HÁ MENOS DE 15 DIAS OU LITÍASE RENAL COM ITU DE REPETIÇÃO	
	() Opção 1: Piperacilina + Tazobactam 4,5g: 01 FA em 100ml de SF 0,9% EV	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
CUTÂNEO	ERISPELA E CELULITE NÃO BOLHOSA	
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV	
	() Opção 2: Oxacilina 500mg: 04 FA em 100ml de SF 0,9% EV de 4/4h	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
	ERISPELA BOLHOSA OU PÉ DIABÉTICO (COM OU SEM NECROSE)	
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml d SF 0,9% EV + Clindamicina 600mg: 01 FA em 100ML SF 0,9% EV	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
SNC	MENINGOCOCO, PNEUMOCOCO OU HAEMOPHYLUS INFLUENZAE	
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
?	INDETERMINADO	
	() Opção 1: Ceftriaxona 1g: 02 FA em 100ml de SF 0,9% EV + Oxacilina 500mg: 04 FA em 100ml SF 0,9% EV de 4/4h	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
X	FORA DO PADRONIZADO	
	(Preencha com medicamento, dose, diluição, via de administração e tempo de infusão)	carimbo e assinatura do(a) médico(a)
FARMÁCIA	DISPENSACÃO DA FARMÁCIA (EXCLUSIVA PARA NEWS ≥ 5) Caso não haja registro adequado, solicitar preenchimento ao(a) médico(a) responsável pela abertura do protocolo ou não dispensar medicação.	
	DISPENSACÃO REALIZADA: () SIM () NÃO	
	DATA: / / HORA: :	carimbo e assinatura do(a) farmacêutico(a) ou auxiliar de farmácia